Faculté de Droit, Sciences économiques & de gestion
Le Mans Université

Le Mans Université

MASTER ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

PANORAMA DES DONNÉES DE SANTÉ

LES INÉGALITÉS TERRITORIALES DANS L'ACCÈS AUX MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Ndéye BAKHOUM

Aquila WILLIAMS

ANNÉE ACADÉMIQUE 2025-2026

I. PROBLÈMATIQUE ET REVUE LITTERAIRE

L'accès aux soins de premier recours constitue un indicateur central de la performance des systèmes de santé. En France, un déséquilibre croissant entre l'offre et la demande des soins primaires a conduit à l'émergence de « déserts médicaux » dans plusieurs territoires. [1]Selon la DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) du ministère de la santé, l'accès aux médecins généralistes a baissé de 1,4% entre 2022 et 2023 sur l'échelle national. Cette situation affecte particulièrement les zones rurales ou périurbaines, où la faible densité de médecins généralistes peut engendrer un allongement des délais de consultation, un accroissement de la proportion des patients sans médecin traitant et, à terme, une dégradation des indicateurs de santé.

Plusieurs travaux ont analysé la question des déserts médicaux et des inégalités territoriales d'accès aux soins en France. L'étude menée par Zeynep Or et Aude Penneau[2] pour l'IRDES souligne que ces disparités sont liées à des facteurs socio-économiques tels que le niveau de revenu ou la structure démographique des territoires. Les auteurs montrent que les populations vivant dans des zones rurales ou défavorisées rencontrent davantage de difficultés pour accéder aux services de santé. De même, les travaux de Ludivine Laurent[3] mettent en évidence que, malgré la mise en place de nombreuses politiques publiques telles que les incitations financières à l'installation des médecins et la suppression du numerus clausus en 2019, les déséquilibres territoriaux persistent. Ces résultats soulignent l'importance d'analyser les inégalités territoriales dans la répartition des médecins afin de mieux comprendre les difficultés d'accès aux soins.

Dès lors, il apparait pertinent d'analyser l'existence d'inégalités territoriales significatives dans la répartition des médecins généralistes en France métropole et d'examiner leur lien avec les caractéristiques socio-économiques des territoires ?

II. DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE

Cette étude s'appuie sur des données issues de sources publiques choisies pour leur fiabilité et leur couverture nationale. Notre base de données est composée de la densité des médecins généralistes par département, qui constitue la variable principale de l'analyse. Ces données ont été récupérées sur l'open data de la DREES, qui fournit des informations détaillées sur la démographie médicale en France.

Afin de déterminer les facteurs susceptibles d'expliquer les disparités territoriales, des variables socio-économiques ont été intégrées dans l'analyse à partir des données de l'INSEE (Institut National de la statistique et des études économiques). Il s'agit notamment du niveau de vie médian, utilisé comme indicateur du niveau économique des territoires, de la part des séniors (population âgés de plus de 60 ans) ainsi que de la densité de la population, reflétant le degré d'urbanisation des territoires. Une des limites de ces données agrégées au niveau départemental est qu'ils ne permettent pas de capter les disparités locales.

[1] https://www.franceinfo.fr/sante/deserts-medicaux/acces-aux-soins-pourquoi-les-communes-rurales-sont- elles-de-plus-en-plus-delaissees_7015958.html
[2] Or, Z., & Penneau, A. (2017). Analyse des déterminants territoriaux du recours aux urgences non suivi d'une hospitalisation. Paris : IRDES (Institut de Recherche et Documentation en Économie de la Santé)
[3] Laurent, L. (2017). *Les déserts médicaux : comprendre et agir*. Paris : Presses de Sciences Po.

Pour examiner la relation entre la densité de médecins généralistes et ces variables socio-économiques, une régression linéaire est estimée selon le modèle suivant :

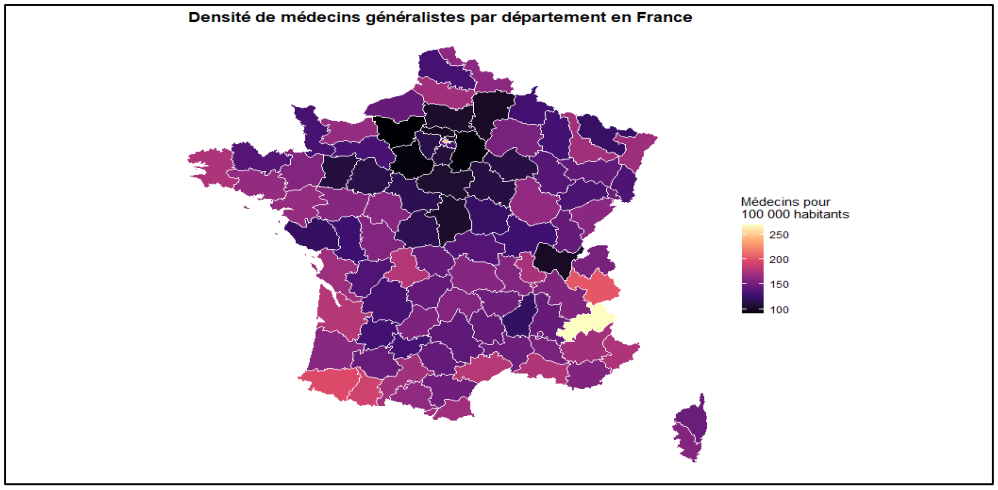
$$^{4}\boldsymbol{Densite_{medecins}} = \boldsymbol{\beta_0} + \boldsymbol{\beta_1}{}^{5}\boldsymbol{Niveau_{vie}} + \boldsymbol{\beta_2}{}^{6}\boldsymbol{Part_{seniors}} + \boldsymbol{\beta_3 densite_pop} + \boldsymbol{\varepsilon}$$

Où $\boldsymbol{\beta_0}$ est la constante, $\boldsymbol{\beta_1, \beta_2, \beta_3}$ représente les coéfficients associes aux variables explicatives et ε le terme d'erreur.

III. RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

La densité de médecins généraliste varie entre 91.16 et 268.13 médecins pour 100000 habitants. La valeur moyenne s'établit à 145.64 médecins/100000hbts, avec une médiane 145.21 ce qui traduit une distribution relativement équilibrée autour de cette valeur.

Graphique 1 : La densité de médecins généralistes par département en 2021



Source : Sortie logiciel R, départements France métropole, 2021

La carte met en évidence des disparités territoriales significatives dans la densité des médecins généralistes en France. Les départements situés dans les grandes métropoles présentent une densité de médecins plus élevée. A l'inverse, les départements dans les zones plus rurales apparaissent moins dotés en médecins généralistes.

L'estimation de notre modèle de régression linéaire montrent que la densité de la population et la part des seniors sont positivement et significativement associées à la densité de médecins généralistes. Les départements plus peuplés et comptant une population plus âgée semblent mieux dotés en médecins. Le niveau de vie médian présente aussi un effet positif mais peu significatif. Toutefois, le coefficient de détermination indique que les variables incluses n'expliquent qu'une faible partie des variations de la densité de médecins entre les départements.

Ces résultats suggèrent que les inégalités territoriales d'accès aux médecins généralistes sont liées à certaines caractéristiques socio-économiques des territoires, mais qu'elles résultent également d'autres déterminants institutionnels et organisationnels non pris en compte dans ce modèle.

---

[4]Densité_médecins:https://data.drees.solidarites-sante.gouv.fr/explore/dataset/la-demographie-des-professionnels-de-sante-depuis-2012/information/

[5]Niveau_vie:https://www.insee.fr/fr/outil-interactif/5367857/details/territoires/30_RPC/31_RNP/31K_FigureT1

[6]Part_seniors et Densité_population : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8242331?sommaire=8242421